



健康資訊

[主頁](#) > [健康資訊](#) > [傳染病](#) > 水痘

水痘



2026年7月21日

病原體

水痘是由水痘帶狀疱疹病毒引起的急性傳染病，多發生在12歲以下的兒童身上。雖然幾乎所有人於感染水痘後都會終身免疫，但水痘病毒仍可能潛伏於人體內，並可在多年後復發引致「帶狀疱疹」，俗稱「生蛇」。

病徵

- 患者通常會出現發燒和痕癢的紅疹。
- 紅疹大概於5天內陸續出現，最初出現於身軀，然後向面部和四肢擴散。
- 這些紅疹先是扁平，及後形成突起的豆狀小水疱，小水疱維持約3 – 4天，然後變乾、結痂。
- 患者通常約於2 – 4星期內痊癒。
- 曾接種水痘疫苗者仍可能感染水痘（稱「突破感染」）。其症狀通常較為輕微或較不典型，水疱數目亦較少，紅疹通常以斑丘疹為主而非水疱，病程通常比未有接種疫苗者較短。

傳播途徑

- 水痘可透過飛沫或空氣傳播。
- 亦可經由直接或間接接觸水痘或帶狀疱疹患者帶有病原體之水疱液、黏膜分泌物而傳播。

潛伏期

10 – 21天，通常14 – 16天

傳染期

通常由患者出疹前1 – 2天，至所有小水疱變乾。水痘的傳染性極高，尤其是在患者出疹的初期。

併發症

水痘屬於輕微疾病，並會自行痊癒。不過，有部分患者的傷口可能會出現細菌感染。抵抗力弱的人士和孕婦，患上嚴重的併發症如肺炎和腦炎的機會較高。初生嬰兒若染上水痘，病情會較嚴重，甚至危及性命。婦女在懷孕初期若染上水痘，可能導致胎兒出現先天性缺陷。

治理方法

- 諮詢醫生有助了解病情；並遵從醫生的建議使用藥物（如退燒和止癢藥物），以紓緩病徵。
- 如出現發燒，應多喝開水和多休息。
- 睡眠時可穿上清潔的棉手套，以免抓破小水疱而引致皮膚發炎及留下疤痕。
- 應避免與孕婦和抵抗力弱的人士接觸。

- 患上水痘的兒童不應返回學校 / 幼稚園 / 幼稚園暨幼兒中心 / 幼兒中心，應留在家中直至所有小水疱變乾（通常在紅疹出現約1星期後），以免把病毒傳染給校內其他同學。
- 家長須留心觀察兒童的病情。如出現持續發燒、拒絕進食、嘔吐或嗜睡等病徵，應及早求診。
- 家長亦要小心觀察家中其他兒童，是否出現水痘的病徵。

預防方法

1. 保持良好的個人衛生

- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前、觸摸扶手或門把等公共設施後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。
- 當出現感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

2. 保持良好的環境衛生

- 定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（即把1 份 5.25% 漂白水與 99 份清水混和）消毒，待15 – 30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。
- 用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1 比 49 稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15 – 30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。
- 保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

3. 免疫接種

- 接種水痘疫苗能有效地預防此病，約9成接種疫苗的人士可以產生免疫能力。
- 在「香港兒童免疫接種計劃」下，兒童接種共兩劑含水痘的疫苗（請參閱「[香港兒童免疫接種計劃](#)」）。家長可向家庭醫生或衛生署母嬰健康院查詢詳情。

帶狀疱疹

水痘帶狀疱疹病毒於水痘患者痊癒後潛藏在體內的神經系統。多年後當身體免疫力下降，有機會誘發自身病毒重新激活，出現帶狀疱疹（俗稱「生蛇」）。患者皮膚出現一種令人痛楚、呈帶狀的紅疹並帶有水泡，一般並不嚴重，出現嚴重併發症或死亡風險不高，及早使用抗病毒藥物治療可加快水泡癒合、減輕症狀和出現併發症的風險。個別較年長及免疫力弱的成人可考慮在諮詢醫生意見後接種帶狀疱疹疫苗，以保護自己免受帶狀疱疹及其併發症影響。

其他語言

印尼語版 Bahasa Indonesia	他加祿語版 Tagalog	泰語版 ไทย
印度語版 हिन्दी	尼泊爾語版 नेपाली	巴基斯坦語版 اردو
越南語版 Tiếng Việt	旁遮普語版 ਪੰਜਾਬੀ	

網上資源